SDD 36 Sujet n°4

Spécialité : Rhumatologie

Date : 15/02/2026
Auteur : Nora MONTREUIL (interne de rhumatologie à Paris)
Relecteur(s) : Dr VANDEBEUQUE (PH Rhumatologie Bégin), Hamza MAKHLOUK (VP ECOS TACFA, interne en cardiologie à Paris)

Domaine d'apprentissage principal	Synthèse d'examens paracliniques
Domaine d'apprentissage secondaire	Iconographie
Item en lien avec la station	128- Ostéopathie fragilisante
Situation(s) de départ en lien avec la station	36- Douleur de la région lombaire 175- Traumatisme rachidien
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	Service de rhumatologie au CHU Patiente de 84 ans

Pour rappel, les domaines d'apprentissage sont :

- Entretien/interrogatoire
- Examen clinique
- Iconographie
- Procédure
- Stratégie diagnostique
- Stratégie pertinente de la prise en charge
- Synthèse des résultats d'examens paracliniques
- Education/prévention
- Annonce/information au patient
- Urgence vitale
- Communication interprofessionnelle

La liste des items de l'EDN se trouve ICI
La liste des situations de départ se trouve ICI

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes un.e rhumatologue au CHU.
Vous recevez dans votre service Mme Jeannot, patiente de 84 ans, suite à une chute.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Analyser les documents à votre disposition
- Proposer et justifier votre diagnostic complet
- Proposer une prise en charge thérapeutique

Vous ne devez pas :

- Proposer des examens complémentaires

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans patient standardisé ou professionnel de santé standardisé.

Annexe 1
Compte-rendu d'hospitalisation

Mme Jeannot, 84 ans

Antécédents :
-Diabète de type 2
-Hypertension artérielle
-Fracture de Pouteau-Colles droite sur chute de sa hauteur, il y a 2 ans

Traitements :
-Metformine 1000mg matin et soir
-Amlodipine 5 mg matin

Gynéco obstétrique : G2P2 ; ménopause à 48 ans

Allergie : 0

Mode de vie : Autonome. Appartement rez de chaussée.
Tabac : 5 cigarettes par jour depuis 50 ans
Alcool : 1 verre par semaine

Histoire de la maladie :
Hier midi, la patiente trébuche sur son tapis et chute. Elle se plaint d'une douleur rachidienne, d'horaire mécanique.
Sa fille appelle immédiatement les secours.
Elles ne rapportent pas de perte de connaissance ni de traumatisme crânien.
Pas de syncope ni douleur thoracique précédant la chute.
Aux urgences : ECG sans anomalie. Imagerie et biologie à disposition

Elle est transférée le lendemain dans notre service de rhumatologie

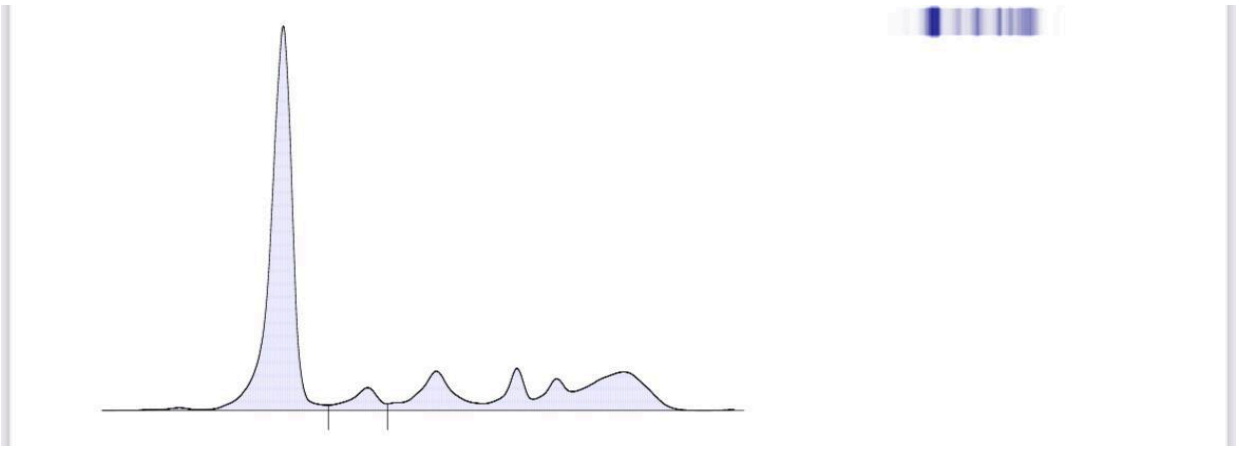
Examen clinique :
1m61 ; 49kg ; IMC 18,9
FC 85bpm ; TA 145/78 mmHg ; T 36,7C ; SpO2 98% AA
Rhumatologique : Douleur à la palpation des épineuses vertébrales
Neurologique ; ROT symétrique, présents aux 4 membres ; pas de déficit moteur ni sensitif ; RCP en flexion ; Hoffman négatif ; Pas de niveau sensitif rachidien ; pas de trouble vésico sphinctérien
Cardiologique : Bruits du cœur régulier sans souffle ; pas d'OMI ; pas de TJ ni RHJ
Respiratoire : Murmures vésiculaires symétriques, sans bruit surajouté

Annexe 2

Mme Jeannot
Prélevée à 7h02

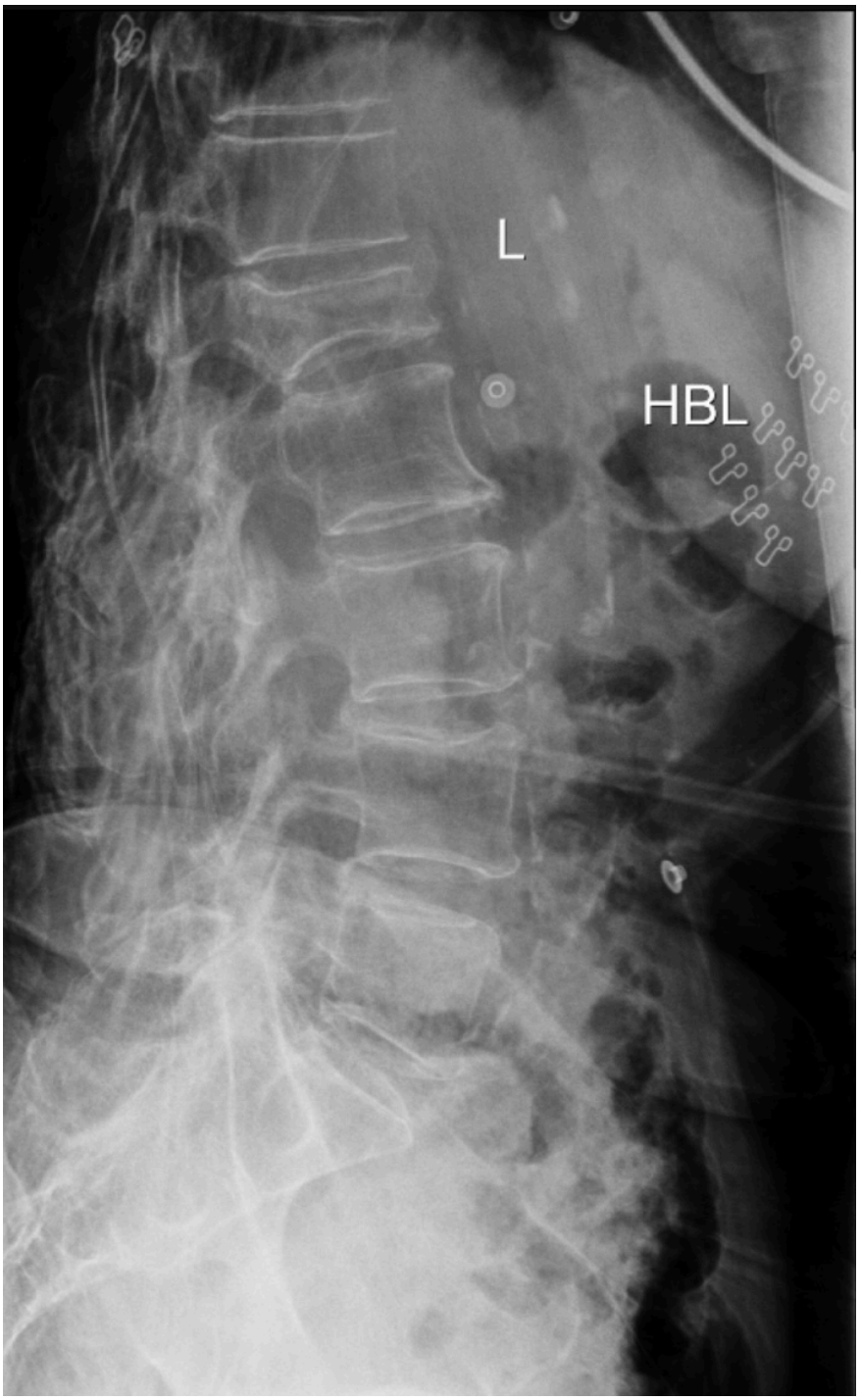
Examen	Valeur	Norme
Hémoglobine	13,1 g/dL	
Hématocrite	40 %	
VGM	91 fL	
Leucocytes	6,4 G/L	
Neutrophiles	3,6 G/L	
Lymphocytes	2,1 G/L	
Monocytes	0,5 G/L	
Eosinophiles	0,15 G/L	
Basophiles	0,05 G/L	
Plaquettes	260 G/L	
CRP	1 mg/L	
Albuminémie	32 g/L	
ASAT	22 UI/L	N : < 35
ALAT	24 UI/L	N : < 35
GGT	18 UI/L	N : < 40
Phosphatases alcalines	70 UI/L	N : 35–120
Calcémie totale	2,15 mmol/L	
Calcémie corrigée	2,31 mmol/L	
Phosphorémie	1,05 mmol/L	
PTH	44 pg/mL	N : 15–65
Créatininémie	70 µmol/L	
DFG (CKD-EPI)	92 mL/min/1,73 m^2	
TSH	1,8 mUI/L	
Calciurie des 24 h	4,3 mmol/24 h	N : 2–6
Vitamine D 25 OH	27 ng/mL	30-70

Annexe 3

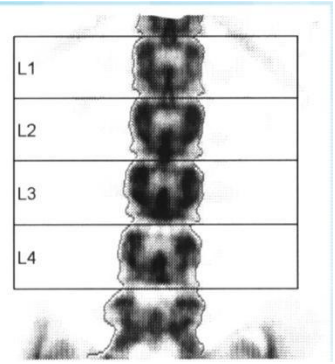


Examen	Valeur	Norme
Protéines totales sériques	62,10 g/L	64-83 g/L
Albumine	32,00 g/L	40,20-47,60 g/L
Alpha 1 globulines	3,30 g/L	2,10-3,50 g/L
Alpha 2 globulines	7,30 g/L	5,10-8,50 g/L
Bêta 1 globulines	4,40 g/L	3,40-5,20 g/L
Bêta 2 globulines	3,80 g/L	2,30-4,70 g/L
Gamma globulines	11,30 g/L	8,00-13,50 g/L
Rapport albumine/globulines	1,06	—

Annexe 4



Annexe 5



Localisation	DMO g/cm2	Tscore
L2-L4	0,64	-1,8
Col fémoral	0,77	-1,5
Col total	0,73	-1,6

ECOS TACFA

GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques			
1	Élimine une compression médullaire	1 pt	☐
2	Élimine une hyperparathyroïdie, justifie par calcémie corrigée normale, Phosphate normale et PTH normale	1 pt	☐
3	Élimine un myélome et justifie par : -Pas de critère CRAB ou pas d'anémie, pas d'insuffisance rénale, pas d'hypercalcémie -Absence de pic d'immunoglobuline	1 pt	☐
4	Absence de fracture pathologique : -Localisation -Pas de recul du mur postérieur -Absence d'ostéolyse -Fracture symétrique	1 pt si au moins 2 éléments	☐
5	Localise la fracture en L1	1 pt	☐
6	Identifie un Tscore inférieur à -1 ou identifie une fracture sévère	1 pt	☐
7	Identifie un traumatisme à basse cinétique	1 pt	☐
8	Identifie les facteurs de risque d'ostéoporose : -Ménopause -Âge -Carence en vitamine D -Faible poids -Antécédent de fracture -Diabète -Tabagisme	1 pt si au moins 4 éléments	☐
9	Diagnostique une ostéoporose primaire fracturaire post ménopausique	1 pt	☐
10	Prescrit une supplémentation en vitamine D	1 pt	☐
11	Prescrit des biphosphonates	1 pt	☐
12	Prescrit selon les apports une supplémentation calcique. Point non validé si calcium en systématique	1 pt	☐
13	Propose de corriger les facteurs de risque : -sevrage tabagique -supplémentation nutritionnelle ou prise en charge diététique	1 pt si au moins 1 élément	☐
Communications et attitudes			

14	**8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES**

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

15	**12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)**

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	**…./15 points**

<u>Éléments de rétroaction</u> :

De manière générale :
-ECOS avec synthèse d'examens paracliniques, il faut bien penser à justifier ses réponses en s'appuyant sur les documents
-Bien justifier son diagnostic mais aussi les diagnostics différentiels les plus fréquents et ou graves
-Même si vous n'avez pas le diagnostic final, vous pouvez tout de même avoir une bonne note en analysant correctement les documents
-Faire une conclusion à la fin "au total je pense à ... car sur le plan clinique… biologique ... radiologique ..."

Ostéoporose :
-En pratique lors d'une ostéoporose primaire fracturaire sévère avec un traumatisme à basse cinétique, on traite systématiquement, sans nécessairement attendre la Densitométrie osseuse
-Ne pas oublier le bilan dentaire avant ou au début du traitement par Biphosphonates
-Concernant l'apport calcique, il se fait en fonction des apports.
-Pour compter les vertèbres : partir du sacrum et remonter L5-L4 etc
-Pour la vitamine D, on supplémente systématiquement même si normale (1 fois par mois ou tous les 6 mois selon le contexte). Dans ce cas précis, la patiente est carencée elle recevra des ampoules de vitD de manière plus rapprochée
-Fracture du poignet est une fracture très évocatrice d'ostéoporose
-Localisation évocatrice d'ostéoporose : sous T3
-La calcémie totale s'interprète avec l'albuminémie. Si hypoalbuminémie, prendre

en compte la calcémie corrigée ou la calcémie ionisée, qui elle ne varie pas avec l'albumine
-Rechercher une compression médullaire, prise en charge neurochirurgicale le cas échéant. Recherche d'un syndrome lésionnel et sous lésionnel ? SD pyramidal ? Troubles vésico sphinctériens ? Déficit moteur ?

Ostéoporose primaire vs secondaire vs ostéomalacie
-Un bilan biologique d'ostéoporose primaire est normal (à confronter avec les atcd ; hypovitaminose D est fréquente dans la population générale, si isolé ne remet pas en cause le diagnostic d'ostéoporose primaire)
-A différencier de l'ostéomalacie par carence en vitamine D (serait très basse et non pas limite), on aurait aussi classiquement une hypocalcémie et hypophosphatémie, augmentation des PAL, hypocalciurie, hyperparathyroïdie secondaire à l'hypocalcémie.

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

Etudiant sur une chaise ; table avec documents Évaluateurs sur une autre table

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours